

Toksyczna karma — *pro-ana, thinspo, „what I eat in a day”*

Treści *pro-ana*, *thinspo*, restrykcyjne „WIEIAD” — codziennie wzmacniają AN voice. Krytyczne dla zdrowienia: cisza medialna, restrukturyzacja feedów.

CZAS: 30 min audytu + tygodnie świadomej kuracji

REALIZACJA: każda faza terapii, krytyczne dla zdrowienia

ŹRÓDŁO: Harper, Sperry & Thompson (2013, *pro-ana websites*); Rodgers (2016, *social media & ED*); Holland & Tiggemann (2016, *Instagram & ED*)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **typy toksycznych treści** (*pro-ana*, *thinspo*, restrykcyjne WIEIAD, „*fitspiration*”, algorytmiczna eskalacja). Sekcja 02 — **siedem kroków detoksu**: audyt → unfollow → block → restrukturyzacja feedów → świadome korzystanie. Sekcja 03 — **audyt mojego feedu**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Treści *pro-ana* („*pro-anorexia*”) i *thinspo* („*thinspiration*”) — społeczności i estetyka glamoryzująca AN, restrykcję, niską masę ciała. Współcześnie: konta na Instagramie, TikToku, Reddit, Tumblr; tagi #thinspo, #proana, #anatis, #skinnycheck; subkultura restrykcyjnych „*what I eat in a day*” (WIEIAD); *fitspiration* sliding into *thinspo*. **Mechanizm szkodliwości:** (1) *normalizacja* restrykcji — pacjent widzi „*inni też tak robią*”; (2) *wzmacnianie AN voice* — każde zdjęcie/wpis to wzmocnienie; (3) *porównania* — paliwo nadwartościowania; (4) *algorytmiczna eskalacja* — algorytmy podsuwają coraz bardziej skrajne treści (Holland & Tiggemann, 2016). Harper i in. (2013): osoby korzystające z *pro-ana* mają *znaczaco* gorsze rokowanie. Rodgers (2016): czas spędzony w mediach społecznościowych koreluje z nasileniem objawów ED. Detoks medialny = *obowiązkowy* komponent leczenia.

01 Typy toksycznych treści — co dokładnie szkodzi

TYP

CHARAKTERYSTYKA I DLACZEGO SZKODZI

<i>Pro-ana</i>	Społeczności glamoryzujące AN. Tagi #proana, #anatis, posty „ <i>tips and tricks</i> ”. Wzajemna „ <i>motywacja</i> ” do restrykcji. Komentarze pochwalne dla niskiej masy.
<i>Thinspo / bonespo</i>	Zdjęcia ekstremalnie szczupłych ciał — często z widocznymi kośćmi (<i>bonespo</i>). Estetyka „ <i>aspiracyjna</i> ”. Tagi #thinspo, #highgap, #skinnycheck, #ribcage. Wizualne paliwo nadwartościowania.
Restrykcyjne WIEIAD	„ <i>What I eat in a day</i> ” z bardzo niską podażą energii. Często prezentowane jako „ <i>zdrowe</i> ” lub „ <i>czyste</i> ”. TikTok i Instagram pełne. Normalizują restrykcję jako lifestyle.
<i>Fitspiration</i> → <i>thinspo</i>	„ <i>Motywacja fitness</i> ” zsuwająca się w glamoryzację skrajności. „ <i>Lean</i> ”, „ <i>shredded</i> ”, obsesyjne ćwiczenia, restrykcyjne diety. Holland & Tiggemann (2016): koreluje z patologią jak <i>thinspo</i> .
Algorytmy	Algorytmy (Instagram, TikTok, YouTube) <i>zaostrzają</i> — gdy pacjent zatrzyma się na pierwszym <i>thinspo</i> , dostaje 10 kolejnych. Każde zatrzymanie wzmacnia podsuwanie. Sama obecność na platformie = ryzyko.

Detoks medialny = obowiązkowy komponent leczenia. Bez tego AN voice jest codziennie karmiona. Pacjent zdrowieje w gabinecie (1h tygodniowo) i wraca do toksyk (2-4h dziennie). Matematyka mówi sama za siebie.

1. **Audyt feeda** — pacjent razem z terapeutą przegląda obserwowane konta, ostatnie polubienia, historię wyszukiwania. Cel: *nazwanie* konkretnych źródeł toksyk. Niektóre są ukryte (sub-konta, save'y).
2. **Unfollow wszystkich pro-ana/thinspo/restrykcyjnych WIEIAD** — bez wyjątków. *Nie „obserwuję, bo motywuje mnie”* — to AN voice tak sobie tłumaczy. Cel: zero kont glamoryzujących restrykcję.
3. **Block + mute tagów** — większość platform pozwala zablokować tagi: #thinspo, #proana, #anatips, #thighgap, #bonespo, #wieiad (z restrykcyjnymi). Czas: 15 min jednorazowo.
4. **Reset algorytmu** — Instagram, TikTok: „*nie interesuje mnie*” przy każdej toksyk-rekomendacji. Algorytm uczy się — po 2–4 tyg. feed się zmienia. Trzeba być konsekwentnym.
5. **Restrukturyzacja feeda** — co *dodać* w miejsce toksyk: konta o pasjach pacjenta (sztuka, książki, podróże, nauka), konta neutralność wobec ciała (ang. *body neutrality*) lub HAES (*Health at Every Size*), konta zdrowienia (ang. *recovery accounts*).
6. **Reguły czasu** — limit dziennego korzystania (apple Screen Time, Android Wellbeing). Wstrzymanie korzystania w wrażliwych momentach: rano, przed snem, przy posiłku. Łatwy do złamania — pomocna kontrola zewnętrzna (terapeuta, rodzic, partner).
7. **Plan zastępczy** — co robić, gdy ręka idzie do telefonu? Lista 5–10 aktywności: spacer, książka, rozmowa, kreatywność, sen. Bez planu — automatyzm powrotu.

KONTA PRO-ANA / THINSPO / RESTRYKCYJNE, KTÓRE OBECNIE OBSERWUJĘ

— bądź szczerzy/-a; ujawnienie to pierwszy krok

TAGI, KTÓRE BĘDĘ BLOKOWAĆ

— #thinspo, #proana, #anatips, #thighgap, #bonespo, #skinnycheck, własne

PIĘĆ KONT, KTÓRE DODAM W MIEJSCE TOKSYK

— moje pasje (sztuka, książki, podróże, nauka), konta zdrowienia (ang. *recovery accounts*), neutralność wobec ciała (ang. *body neutrality*), HAES

LIMIT DZIENNEGO CZASU W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

— konkretna liczba minut; ustawienie w aplikacji

TRZY AKTYWNOŚCI, GDY RĘKA IDZIE DO TELEFONU

— spacer, książka, rozmowa, kreatywność, ćwiczenie oddechowe, sen

Klucz: detoks medialny nie jest *opcjonalny* — jest *warunkiem* zdrowienia. Bez niego AN voice jest karmiona codziennie, niezależnie od pracy w gabinecie. Pacjent często *opiera się* detoksowi: „*to moje motywacje*”, „*tylko ja kontroluję, co oglądam*” — to AN voice, nie pacjent. **Komunikat dla pacjenta:** „*te konta nie są Twoim wyborem — algorytm je Tobie podsuwa, a AN voice się tym karmi. Cisza medialna jest aktem oporu, jednym z najpotężniejszych w terapii*”. U młodzieży — rola rodziców kluczowa (monitorowanie, kontrola).

⚠️ **Cyber-bullying i traumatyczne treści:** u niektórych pacjentów media społecznościowe są źródłem traumy (komentarze, *body shaming*, nagonki — ang. *pile-on*). Detoks musi obejmować nie tylko pro-ana, ale też usunięcie kontaktów krzywdzących. W skrajnych przypadkach — czasowe cyfrowa pauza (ang. *digital sabbatical*) (1–3 mies. bez mediów społecznościowych) jako interwencja terapeutyczna.